第 六 章

戒：不是意志力的事

> 戒不掉通常不是「你不行」，是你只带了一件工具。

厕所隔间里，手机屏幕亮着。搜索框里打着「戒烟 方法」，删掉，又打「戒烟 几天 难受」。

外面有人敲门。他把手机塞回兜里，冲了水，出来洗手。

镜子里的自己看了一眼，又低下去。

写字楼厕所，午休

这个画面里没有信息差。他知道吸烟有害，知道该戒，也知道去哪儿搜。他缺的是一次成功的经验。

而「成功」这件事，很少靠一次下定决心完成。

6.1 它是病，不是品格

世界卫生组织的疾病分类里，烟草依赖有独立的编码（ICD-10：F17.2），归在精神与行为障碍项下。这句话的意思是：它有诊断标准，有病理机制，有治疗方法。

也意味着：戒不掉不是「没毅力」，是「没治疗」。

只靠意志力硬戒，一年后的成功率通常只有个位数，常见估计是不足 5%。这不是劝退，恰恰相反——它说明失败是默认结果，成功需要额外的工具。

把这件事当成品格问题，代价很实际：失败一次，人会觉得自己不行；失败三次，就不试了。而归因错了，方法就永远找不对。

6.2 有效的，是一个组合

目前证据最硬的方案，是药物加行为支持。世界卫生组织和中国临床戒烟指南的口径一致：规范的戒烟治疗，可以把成功率提高 1–2 倍。

三类一线药物：

1. **尼古丁替代疗法**
   贴片、咀嚼胶。用少量尼古丁缓解戒断，再逐步减量。非处方可及，但仍建议先咨询医生或药师。

2. **盐酸安非他酮缓释片**
   处方药。作用于与成瘾相关的神经通路，需医生评估，有癫痫史等情况不能用。

3 **酒石酸伐尼克兰**

处方药。部分激动尼古丁受体，既减轻戒断，也降低吸烟的快感。效果在三类里通常最强，同样需医生评估。

行为支持不是「聊聊天」。它包括设定戒烟日、识别触发场景、处理戒断、应对复吸、调整作息。戒烟门诊做的就是这个，热线和小程序做的也是这个。

关键在叠起来，不在选一个。药物处理生理，行为支持处理场景，环境处理诱因。三样都在，成功率才像一个可以期待的数。

6.3 在哪儿找到这些

戒烟门诊。多数三甲医院的呼吸科或控烟门诊设有。微信搜「中国戒烟平台」小程序，可以查附近的门诊并直接挂号。

全国专业戒烟热线：400-808-5531。免费，有人接，可以问「我这种情况该怎么开始」。

12320。卫生热线，可以转戒烟咨询，也可以问本地戒烟门诊的地址。

「中国戒烟平台」小程序。中国疾控中心与世界卫生组织驻华代表处联合推出，含戒烟门诊、戒烟热线、吸烟日记、用药助手。

「在线戒烟」小程序。中日友好医院做的，报名后按节点推送指导，周期约六个半月。

如果你还在上学，还有一条：先去校医室。校医做不了治疗，但能做初筛、能判断要不要转诊。未成年人用戒烟药物，必须由医生评估。

6.4 身体什么时候开始修

戒断难受是真的，但修复也是真的，而且开始得比想象中快。

20 分钟

心率和血压开始下降，回到接近平时的水平。

12 小时

血里的一氧化碳降到接近正常，携氧能力开始恢复。

2 周 – 3 个月

循环改善，肺功能开始上升，走路和爬楼没那么喘。

1 – 9 个月

咳嗽和气短减少，气道里的纤毛重新长出来，开始把积的东西往外清。

1 年

冠心病风险降到持续吸烟者的一半。

10 年

肺癌死亡风险降到持续吸烟者的一半。

15 年

冠心病风险接近从不吸烟的人。

时间线来源：美国疾病控制与预防中心（CDC）、世界卫生组织戒烟获益说明。

这张表最有用的一行，是第二行。十二小时——睡一觉的工夫，血里的一氧化碳就正常了。很多人戒的第一天就觉得「整个人清醒了」，不是错觉。

6.5 复吸不是回到原点

多数成功戒烟的人，都经历过不止一次失败。复吸说明的是「这次的方案不够」，不是「你这辈子戒不掉」。

复盘的时候看三件事：是什么场景触发的（饭后、喝酒、吵架、考试前）；当时手上有什么工具（药、替代品、人）；下次换什么。

把复吸当数据，不当判决。这句话听起来像安慰，其实是方法——因为只有把它当数据，你才会去改方案；当成判决，你只会觉得自己不行。

戒烟不是一场意志力的考试，是一次需要工具的治疗。工具不齐，考不过很正常。